

ANTICOAGULAÇÃO — DROGA + REVERSÃO

ANTICOAGULANTES — COMPARATIVO

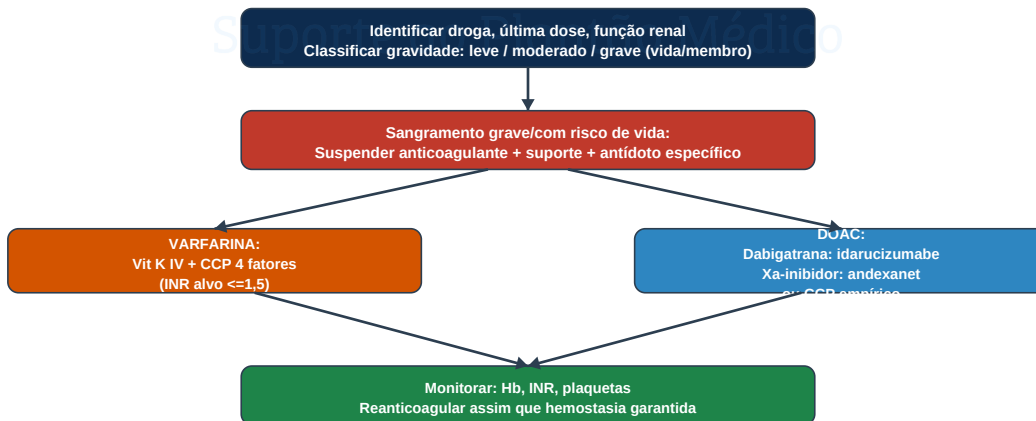
Droga	Mecanismo/Alvo	Monitorização	Antídoto
Heparina não fracionada (HNF)	Anti-IIa + Anti-Xa (via AT-III)	TTPA 1,5-2,5× VN	Protamina 1 mg/100 UI HNF
HBPM (enoxaparina, dalteparina)	Principalmente Anti-Xa	Anti-Xa (obeso, renal, gestante)	Protamina parcial (60%)
Fondaparinux	Anti-Xa seletivo	Anti-Xa (raro)	Sem antídoto específico
Varfarina	Inibe vitamina K (II, VII, IX, X, C, S)	INR (alvo 2-3 ou 2,5-3,5)	Vitamina K + CCP ou PFC
Dabigatrana (DOAC)	Inibe trombina (fator IIa) diretamente	Tempo de trombina diluído	Idarucizumabe (Praxbind)
Rivaroxabana/Apixabana (DOAC)	Inibe fator Xa diretamente	Anti-Xa calibrado (opcional)	Andexanet alfa (Ondexxya)

REVERSÃO DE URGÊNCIA — SANGRAMENTO GRAVE

Droga	Antídoto / Reversão	Dose / Observações
HNF IV	Protamina sulfato IV	1 mg por cada 100 UI HNF das ÚLTIMAS 4h (máx 50 mg) — infundir lento <5 mg/min (risco de hipotensão)
HBPM SC	Protamina parcial	1 mg por 1 mg enoxaparina — eficácia parcial (neutraliza ~60% da atividade anti-Xa)
Varfarina (INR>10 + sangramento)	Vitamina K + CCP	Vitamina K 10 mg IV + CCP 4 fatores 25-50 UI/kg (reversão em <1h)
Varfarina (INR 4-10 sem sangramento)	Vitamina K oral	Vitamina K 2,5-5 mg VO — INR normaliza em 24-48h
Dabigatrana	Idarucizumabe	5 g IV (2 frascos de 2,5 g) — reverter em <5 min; indicar em sangramento grave ou urgência cirúrgica
Rivaroxabana/Apixabana	Andexanet alfa OU CCP 4f empírico	CCP 4 fatores 25-50 UI/kg se andexanet indisponível; andexanet alfa segundo peso/dose recente

SANGRAMENTO EM USUÁRIO DE ANTICOAGULANTE

SANGRAMENTO — GRAVIDADE + ANTÍDOTO



ANTICOAGULAÇÃO TERAPÊUTICA — INDICAÇÕES E ALVOS

Indicação	Droga de escolha	Alvo / Duração
TVP/TEP não provocado	DOAC (rivaroxabana, apixabana)	3-6 meses; indefinido se fator persistente
FA não valvar	DOAC (apixabana preferida)	CHA2DS2-VASc ≥ 2 H/ ≥ 3 M → anticoagular cronicamente
FA valvar / prótese mecânica	Varfarina	INR 2-3 (bioprótese) ou 2,5-3,5 (mecânica mitral)
IAM + trombo intracavitário	Varfarina ou DOAC	3 meses; ecocardiograma de controle
Trombofilia com TEV recorrente	DOAC indefinido	Avaliar trombofilia (antifosfolípide = varfarina)
Profilaxia cirúrgica	HBPM (enoxaparina 40 mg SC/d)	Iniciar 12h antes ou 12h após — conforme risco

SITUAÇÕES ESPECIAIS

Anticoagulação na Gravidez

- HBPM: droga de escolha em toda a gestação (não atravessa placenta)
- Varfarina: teratogênica no 1o trimestre; suspender antes do parto
- DOACs: contraindicados na gestação
- Dose: enoxaparina 1 mg/kg 12/12h (terapêutica) ou 40 mg/d (profilática)
- Monitorar: anti-Xa 4h após dose (alvo 0,6-1,0 UI/mL terapêutico)
- Parto: suspender HBPM 24h antes de anestesia regional

Perioperatório — Bridge Therapy

- Varfarina: suspender 5 dias antes; bridge com HBPM se alto risco (prótese mecânica, FA + AVC recente)
- DOAC de curta ação: suspender 24-48h (48-72h se CíCr < 50 mL/min)
- Baixo risco trombótico: não fazer bridge — aumenta sangramento sem benefício
- Alto risco: HBPM profilática ou terapêutica conforme indicação
- Reiniciar: HBPM profilática 12-24h após cirurgia; DOAC/varfarina quando hemostasia segura

CHECAR ANTES DE ANTICOAGULAR

NEVER SKIP

- ☐ Confirmar indicação: escore de risco trombótico vs hemorrágico (HAS-BLED, CHA2DS2-VASc)
- ☐ Função renal: CíCr (HBPM e DOACs contraindicados se CíCr $< 15-30$ mL/min)
- ☐ Peso extremo: obeso (> 120 kg) ou caquético → usar anti-Xa para ajuste de HBPM
- ☐ Interações: rifampicina, carbamazepina, amiodarona, antifúngicos (varfarina/DOACs)
- ☐ Alergias: heparina — checar TAHIT se histórico de plaquetopenia pós-heparina
- ☐ Sinais de TAHIT: queda de PLQ $> 50\%$ após 5-10 dias de heparina → parar, usar argatroban

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente em uso de varfarina com INR 12 e sangramento digestivo ativo. Qual a reversão mais rápida e eficaz?

- A) Vitamina K 10 mg VO e aguardar 24-48h
- B) Suspender varfarina e transfundir hemácias
- C) Vitamina K 10 mg IV + CCP 4 fatores (25-50 UI/kg) — reversa em <1 hora
- D) Plasma fresco congelado isolado 10 mL/kg
- E) Vitamina K 10 mg IV e aguardar 6-12h

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com FA em uso de dabigatrana sofre sangramento intracraniano grave. Qual antídoto específico deve ser usado?

- A) Vitamina K IV
- B) Protamina 50 mg IV
- C) Idarucizumabe (Praxbind) 5 g IV
- D) Andexanet alfa
- E) Plasma fresco congelado

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual anticoagulante é CONTRAINDICADO durante a gestação pelo risco teratogênico?

- A) Enoxaparina
- B) Heparina não fracionada
- C) Varfarina no primeiro trimestre
- D) Fondaparinux
- E) Dalteparina

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Paciente anticoagulado com heparina não fracionada há 5 dias evolui com queda de plaquetas de 280k para 90k e novo trombo. Qual é a hipótese diagnóstica e conduta?

- A) CIVD — transfundir plaquetas e plasma
- B) Trombocitopenia induzida por heparina (TAHIT tipo 2) — suspender heparina e usar argatroban
- C) Sangramento pós-heparina — reverter com protamina
- D) Sepses — hemoculturas e antibiótico
- E) Trombocitopenia de diluição — transfusão de plaquetas

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com FA não valvar. CHA2DS2-VASc = 3. Qual droga é preferida para anticoagulação crônica?

- A) Aspirina 100 mg/dia
- B) Varfarina com INR alvo 2-3
- C) DOAC (apixabana ou rivaroxabana) — melhor perfil benefício/risco que varfarina em FA não valvar
- D) Enoxaparina subcutânea indefinidamente
- E) Clopidogrel isolado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

INR 12 + sangramento ativo = reversão urgente. Vitamina K IV demora 6-12h. CCP 4 fatores repõe fatores II, VII, IX, X imediatamente (em <15-30 min). Combinação vitamina K + CCP é o padrão para sangramento grave em varfarina. PFC tem grande volume e reversão mais lenta.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Dabigatrana (inibidor de trombina): antídoto específico = idarucizumabe (Praxbind), anticorpo monoclonal que neutraliza dabigatrana em <5 min. Dose: 5 g IV (2 frascos). Andexanet é para inibidores de fator Xa (rivaroxabana, apixabana). Vitamina K não tem papel nos DOACs.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Varfarina é teratogênica no 1o trimestre (embriopatia varfarínica: ossos, SNC). Contraindicada em toda a gestação preferentemente — usar HBPM (não atravessa placenta). Pode ser usada no 2o e 3o trimestres em situações específicas (prótese mecânica), mas com risco.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

TAHIT tipo 2 (Trombocitopenia imune por heparina): queda >50% de plaquetas em 5-10 dias + novo trombo (paradoxo). Mediada por anticorpos contra complexo heparina-PF4. Conduta: suspender TODA heparina (inclusive HBPM) imediatamente + usar anticoagulante alternativo (argatroban, fondaparinux). NÃO transfundir plaquetas.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

FA não valvar com CHA2DS2-VASc ≥ 2 (homem) ou ≥ 3 (mulher): anticoagulação está indicada. DOACs (apixabana, rivaroxabana, dabigatrana) são preferidos sobre varfarina por menor risco de sangramento intracraniano, sem necessidade de monitoramento regular. FA valvar (prótese mecânica, estenose mitral) = varfarina.

SM24
Suporte ao Plantão Médico